

1. La fièvre rhumatismale est une affection multisystémique consécutive causée par une infection laryngée.	1. Faux
2. La fièvre rhumatismale est la 1 ^{ère} cause mondiale d'affection cardiaque chez l'enfant et le jeune adulte.	2. Vrai
3. Le rhumatisme articulaire aigu est une cause fréquente de valvulopathies dans les pays occidentaux.	3. Faux
4. Le staphylocoque bêta hémolytique du groupe A est responsable de la fièvre rhumatismale.	4. Faux
5. La fièvre rhumatismale est la 1 ^{ère} cause de valvulopathies dans le monde.	5. Vrai
6. La réponse immunitaire à l'infection causant le RAA survient généralement dans les 3 jours suivant l'infection.	6. Faux
7. La fièvre rhumatismale affecte principalement le cœur, mais peut également affecter d'autres organes.	7. Vrai
8. La valvulite dans la fièvre rhumatismale affecte généralement la valve aortique.	8. Faux
9. La polyarthrite dans la fièvre rhumatismale atteint les grosses articulations de façon asymétrique et migratoire.	9. Vrai
10. La polyarthrite dans la fièvre rhumatismale dure 1 à 3 mois en l'absence de traitement mais répond en moins de 48h à l'aspirine.	10. Faux
11. La réaction immunitaire post-streptococcique produit une inflammation nodulaire (« d'Aschoff ») au niveau de l'endocarde, du myocarde et du péricarde et provoque une réaction fibrosante calcifiante.	11. Vrai

12. Parmi les différents organes touchés par le RAA, seul le cœur peut présenter des séquelles chroniques.	12. Vrai
13. Le RAA peut se manifester par un érythème cutané marginé prurigineux et serpigineux sur le thorax.	13. Faux
14. Le rhumatisme articulaire aigu peut provoquer des petits nodules sous-cutanés sur la face d'extension des articulations et sur l'occiput.	14. Vrai
15. La fièvre rhumatismale induit une insuffisance valvulaire aiguë.	15. Faux
16. La chorée de Sydenham survient 3 mois après le RAA et se résout spontanément en 1 à 2 semaines.	16. Vrai
17. Le Streptocoque du groupe A possède des épitopes en commun avec la myosine cardiaque et des protéines membranaire du sarcolemme.	17. Vrai
18. Les nodules sous-cutanés dans la fièvre rhumatismale sont fermes et non mobiles.	18. Faux
19. La majorité des angines de l'adulte sont d'origine virale.	19. Vrai
20. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est souvent responsable d'angines entre 1 et 5 ans.	20. Faux
21. Un frottis de détection rapide est plus sensible que la culture pour détecter le streptocoque bêta hémolytique du groupe A.	21. Faux
22. La culture n'est réalisée que si le frottis de détection rapide du streptocoque du groupe A est négatif.	22. Vrai
23. Le frottis de détection rapide est très spécifique d'antigène ou d'ARN du streptocoque du groupe A.	23. Vrai

24. La culture pharyngée est toujours positive pour le streptocoque du groupe A lors des symptômes.	24. Faux
25. Les anticorps anti-streptocoque ASLO sont spécifique du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.	25. Faux
26. Le taux de ASLO est plus élevé lors des symptômes cliniques de RAA.	26. Vrai
27. L'échographie cardiaque est un examen complémentaire utile dans le diagnostic de la fièvre rhumatismale.	27. Vrai
28. La pénicilline est le traitement de choix pour les pharyngites causées par le Streptocoque du groupe A.	28. Vrai
29. Le traitement de la crise aiguë de fièvre rhumatismale comprend le repos au lit et l'administration d'aspirine pour diminuer les douleurs articulaires.	29. Vrai
30. Les corticostéroïdes sont plus efficaces que l'aspirine dans le traitement de la fièvre rhumatismale mais causent plus d'effets indésirables.	30. Faux
31. Un traitement préventif à base de benzathine pénicilline G intra-musculaire tous les mois ou de pénicilline V per os deux fois par jour est administré pendant 20 ans pour prévenir les récurrences d'angine à streptocoques.	31. Faux
32. Une prévention secondaire médicamenteuse peut être administré à vie après une angine streptococcique selon la sévérité de la valvulopathie et le degré d'exposition au streptocoque du groupe A.	32. Vrai
33. La valvulite du RAA affecte plus souvent la valve mitrale que la valve aortique.	33. Vrai
34. Seulement 50% des patients atteints de fièvre rhumatismale développent des séquelles.	34. Vrai

35. 15% des malades présentent une fièvre rhumatismale après une épidémie de pharyngites à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.	35. Faux
36. Une valve fortement atteinte par le RAA continuera à se détériorer car elle génère des flux turbulents.	36. Vrai
37. La chorée de Sydenham dans la fièvre rhumatismale se résout spontanément en quelques jours.	37. Faux
38. L'amoxicilline est inefficace dans le traitement des pharyngites à streptocoques.	38. Faux
39. La fièvre rhumatismale touche principalement les adultes.	39. Faux
40. Sur 100 malades atteints d'angines à streptocoque A, environ 8 patients développeront une fièvre rhumatismale et 4 d'entre eux présenteront des séquelles.	40. Vrai
41. La sténose aortique est un trouble de l'éjection ventriculaire droite.	41. Faux
42. La sténose aortique d'origine dégénérative est associée au diabète, à l'hypercholestérolémie et à des altérations du métabolisme phosphocalcique.	42. Vrai
43. La prévalence de la sténose aortique augmente avec l'âge.	43. Vrai
44. La sténose aortique touche 50% des personnes de plus de 85 ans.	44. Faux
45. La bicuspidie aortique affecte environ 4% de la population.	45. Faux
46. La bicuspidie aortique est 4 fois plus fréquente chez le sujet masculin.	46. Vrai

47. La bicuspidie aortique nécessite un dépistage familial au 2 ^{ème} degré de parenté.	47. Faux
48. La bicuspidie aortique est associée à la coarctation aortique et à la dissection aortique.	48. Vrai
49. La sténose aortique touche 5% des personnes de plus de 65 ans.	49. Faux
50. Les patients atteints de sténose aortique deviennent rapidement symptomatiques.	50. Faux
51. La pronostic de la sténose aortique est de 50% après 2 ans chez le patient symptomatique.	51. Vrai
52. L'hypertrophie ventriculaire gauche réduit la tension pariétale.	52. Vrai
53. L'élévation de la pression dans l'oreillette gauche favorise la fibrillation auriculaire en cas de sténose aortique.	53. Vrai
54. L'hypertrophie ventriculaire gauche réduit l'élasticité ventriculaire, augmente la consommation en O2 et réduit le flux coronaire épicaordique.	54. Faux
55. Un ventricule hypertrophié ne se laisse remplir qu'au prix d'une pression systolique augmentée.	55. Faux
56. La sténose aortique peut être congénitale.	56. Vrai
57. La perfusion coronaire sous-endocardique se fait d'autant mieux durant la diastole que la pression intra-ventriculaire est basse.	57. Vrai
58. La sténose aortique peut causer une angine de poitrine en l'absence de lésion coronaire épicaordique.	58. Vrai
59. Le souffle de la sténose aortique est holosystolique.	59. Faux

60. La sténose aortique peut provoquer une syncope même au repos.	60. Vrai
61. L'effort est très mal toléré en cas de sténose aortique car il entraîne une vasodilatation périphérique avec une augmentation du débit cardiaque et provoque une hypotension rapide.	61. Faux
62. La dyspnée est un symptôme tardif de sténose aortique qui passe souvent inaperçu.	62. Vrai
63. Le massage cardiaque permet difficilement de sauver le patient en mort subite en cas de sténose aortique.	63. Vrai
64. Le souffle d'insuffisance aortique est systolique et éjectionnel.	64. Faux
65. Le souffle de sténose aortique irradie vers les carotides et parfois vers l'apex du cœur.	65. Vrai
66. La sténose aortique se manifeste par un souffle crescendo-décrescendo à l'auscultation cardiaque.	66. Vrai
67. Le souffle de sténose aortique débute après le B1 et s'arrête avant le B2.	67. Vrai
68. Le B2 aortique disparaît en cas de sténose aortique.	68. Faux
69. Le souffle d'insuffisance mitrale est holosystolique.	69. Vrai
70. L'ECG montre souvent une hypertrophie ventriculaire gauche dans la sténose aortique.	70. Vrai
71. L'indice de Sokolow permet de diagnostiquer une hypertrophie ventriculaire droite à l'ECG.	71. Faux
72. La radiographie thoracique montre une dilatation aortique post-sténotique mais ne permet pas de voir les calcifications valvulaires aortiques.	72. Faux

73. La perte de mobilité des cuspidés entraîne une augmentation de la surface valvulaire aortique à l'échographie.	73. Faux
74. L'échographie est indispensable en cas de sténose aortique pour rechercher d'autres pathologies valvulaires associées.	74. Vrai
75. L'épreuve d'effort est recommandée chez les patients présentant une sténose aortique symptomatique.	75. Faux
76. Le cathétérisme cardiaque et la coronarographie sont recommandés dans certaines indications en cas de sténose aortique.	76. Vrai
77. La surveillance échographique est recommandée pour les patients asymptomatiques avec une fonction ventriculaire gauche normale.	77. Vrai
78. La sclérose aortique touche 50% des personnes de plus de 85 ans.	78. Vrai
79. Le remplacement de la valve aortique sténosée n'est pas réalisé chez les patients asymptomatiques.	79. Faux
80. L'apparition des symptômes de sténose aortique survient vers 20-50 ans en cas de bicuspidie aortique, vers 50-60 ans en cas de pathologie rhumatismale et vers 70-80 ans en cas de dégénérescence de la valve.	80. Faux
81. L'apparition des symptômes de sténose aortique annonce une réduction rapide de l'espérance de vie.	81. Vrai
82. Tous les patients asymptomatiques nécessitent une intervention chirurgicale pour traiter la sténose aortique.	82. Faux
83. La dilatation du ventricule gauche est le signe tardif d'une sténose aortique.	83. Vrai

84. La valve aortique ne peut pas être remplacée par une bioprothèse car elle est soumise à une pression trop importante.	84. Faux
85. Le remplacement de la valve aortique sténosée est recommandé chez les patients asymptomatiques avec une fonction ventriculaire gauche altérée.	85. Vrai
86. Le remplacement de la valve aortique est recommandé chez les patients symptomatiques avec une sténose aortique serrée.	86. Vrai
87. La valve aortique peut être remplacée par une bioprothèse ou une valve mécanique.	87. Vrai
88. L'anti-agrégation ou l'anticoagulation orale peut être arrêtée 3 mois après l'implantation d'une bioprothèse.	88. Vrai
89. Les valves mécaniques nécessitent une anticoagulation orale par héparine à vie.	89. Faux
90. Les bioprothèses ont une durée de vie limitée et sont donc réservés aux patients de plus de 65 ans.	90. Vrai
91. L'INR doit être maintenu entre 1 et 2 pour les patients avec une valve mécanique.	91. Faux
92. L'intervention de Bentall consiste à remplacer l'aorte descendante par une prothèse en dacron.	92. Faux
93. Le TAVI est une option de traitement pour les patients jeunes avec une sténose aortique serrée.	93. Faux
94. Le TAVI est réalisé par abord transfémoral.	94. Vrai
95. Les patients de moins de 75 ans sont de bons candidats pour le TAVI.	95. Faux

96. La bicuspidie aortique est une contre-indication absolue au TAVI.	96. Vrai
97. Les valves mécaniques sont recommandées pour les patients âgés de plus de 65 ans.	97. Faux
98. Les valves mécaniques ont une durée de vie limitée.	98. Faux
99. La valve aortique sténosée ne peut pas être remplacée par une valve mécanique si le patient présente une contre-indication aux vitamines K.	99. Faux
100. Les valves mécaniques ont une longue durée de vie mais nécessitent une anticoagulation orale par antivitamines K à vie.	100. Vrai
101. Après le remplacement d'une valve aortique par une valve mécanique, l'INR doit être compris entre 2 et 3 ou entre 2,5 et 3,5 si le patient présente d'autres facteurs de risque thrombo-emboliques.	101. Vrai
102. Le TAVI nécessite une ouverture chirurgicale minimale du thorax.	102. Faux
103. Le TAVI est impossible si la taille de l'anneau aortique est incompatible avec les prothèses existantes.	103. Vrai
104. Le TAVI consiste à placer une prothèse mécanique par voie artérielle dans la valve aortique sténosée.	104. Faux
105. Le TAVI nécessite la prise de petites doses d'aspirine (ou de clopidogrel en cas d'allergie) à vie.	105. Vrai
106. Le TAVI est contre-indiqué en l'absence d'accès artériel ou si les artères coronaires sont implantées à proximité de la valve.	106. Vrai

107. Le TAVI est contre-indiqué en présence d'un thrombus auriculaire gauche.	107. Faux
108. Le TAVI consiste à placer une prothèse biologique par voie artérielle dans la valve aortique sténosée.	108. Vrai
109. Les valves mécaniques nécessitent une anticoagulation orale par clopidogrel.	109. Faux
110. Les patients atteints de sténose aortique restent asymptomatiques pendant une longue période.	110. Vrai
111. La sténose aortique se manifeste par un angor en l'absence de lésions coronaires, par des syncopes et par une dyspnée.	111. Vrai
112. Le TAVI est réservé aux patients <75 ans ou quand la chirurgie cardiaque est impossible ou trop risquée.	112. Faux
113. L'insuffisance aortique peut être causée par une endocardite.	113. Vrai
114. La surcharge en volume du ventricule gauche est commune à toutes les causes d'insuffisance aortique.	114. Vrai
115. L'insuffisance aortique est causée par une altération valvulaire dans 30% des cas.	115. Vrai
116. Un traumatisme thoracique majeur peut causer une insuffisance aortique.	116. Vrai
117. L'insuffisance aortique est causée dans la majorité des cas par une dilatation de l'anneau aortique.	117. Faux
118. Le syndrome de Marfan est une maladie autosomique récessive.	118. Faux
119. Le syndrome de Marfan augmente le risque d'insuffisance aortique et de prolapsus mitral.	119. Vrai
120. L'insuffisance aortique chronique est bien tolérée même à l'effort.	120. Vrai

121. Le syndrome d'Elhers-Danlos est une maladie héréditaire du tissu conjonctif qui peut provoquer une dilatation de l'anneau valvulaire et entraîner une insuffisance aortique.	121. Vrai
122. L'insuffisance aortique est induite par une pathologie congénitale comme la bicuspidie aortique ou l'anévrisme du sinus de Valsalva dans 10% des cas.	122. Vrai
123. La dissection ou un anévrisme de l'aorte ascendante ou l'aortite peuvent entraîner une sténose aortique.	123. Faux
124. L'insuffisance aortique aiguë peut être induite par une endocardite ou une dissection aortique.	124. Vrai
125. L'insuffisance aortique aiguë provoque un œdème pulmonaire hémodynamique par une augmentation importante du niveau de pression en amont.	125. Vrai
126. L'insuffisance aortique aiguë est caractérisée par une fermeture retardée de la valve mitrale.	126. Faux
127. L'insuffisance aortique chronique est le plus souvent due à l'adaptation du cœur à une insuffisance aiguë.	127. Faux
128. L'insuffisance aortique chronique est caractérisée par une dilatation progressive du ventricule gauche.	128. Vrai
129. La fonction contractile du ventricule gauche reste normale dans l'insuffisance aortique chronique.	129. Faux
130. La pression diastolique du VG reste longtemps normale en cas d'insuffisance aortique chronique.	130. Vrai
131. Tout comme la sténose aortique, l'insuffisance aortique chronique entraîne une dilatation progressive du ventricule gauche sans augmentation de l'épaisseur pariétale.	131. Faux

132. L'hypertrophie ventriculaire gauche est de type concentrique dans l'insuffisance aortique chronique.	132. Faux
133. La fraction d'éjection du ventricule gauche dilaté reste longtemps normale en cas d'insuffisance aortique.	133. Vrai
134. L'insuffisance aortique chronique est bien tolérée à l'effort car l'augmentation de la fréquence cardiaque raccourcit la durée de la systole et réduit l'importance de la fuite.	134. Faux
135. La dysfonction myocardique dans l'insuffisance aortique chronique est irréversible.	135. Faux
136. L'insuffisance aortique peut être asymptomatique pendant longtemps.	136. Vrai
137. Le patient asymptomatique atteint d'insuffisance cardiaque ne doit pas être opéré si la contraction myocardique est intacte.	137. Faux
138. Le ventricule normal peu élastique supporte très mal une insuffisance aortique aigue mais le ventricule progressivement dilaté et rendu élastique supporte très bien une insuffisance aortique chronique.	138. Vrai
139. Selon Frank-Starling, plus le cœur est étiré pendant la diastole, plus la force de contraction est faible.	139. Faux
140. La dyspnée est souvent un symptôme précoce de l'insuffisance aortique.	140. Faux
141. L'augmentation importante et rapide de la pression télédiastolique du ventricule gauche entraîne une fermeture prématurée de la valve mitrale en cas d'insuffisance aortique aigue.	141. Vrai
142. Il y a une augmentation de la précharge et de la postcharge en cas d'insuffisance aortique.	142. Vrai

143. La mortalité après remplacement valvulaire aortique s'accroît quand la dilatation ventriculaire gauche devient trop importante.	143. Vrai
144. Les lipothymies et les malaises pré-syncopaux sont fréquents quand la PAD est fortement élevée.	144. Faux
145. Le remplissage du ventricule gauche augmente fortement en cas de sténose aortique car le flux de régurgitation s'ajoute au flux mitral.	145. Faux
146. L'insuffisance aortique peut se manifester par de l'angor car la pression télédiastolique du ventricule gauche augmente et s'oppose à la perfusion coronaire sous-endocardique.	146. Vrai
147. L'insuffisance aortique se manifeste par une augmentation de la pression artérielle diastolique.	147. Faux
148. Le signe de Musset consiste en des mouvements de la tête rythmée par les battements cardiaques et est un signe classique de l'insuffisance aortique grave.	148. Vrai
149. La sténose aortique est caractérisée par une grande différence de pression systolo-diastolique.	149. Faux
150. La dyspnée, l'angor et les signes de bas débits sont tardifs mais dominant le tableau clinique d'insuffisance cardiaque quand la fonction myocardique est altérée.	150. Vrai
151. Le pouls unguéal « de Quincke » est un signe typique de l'insuffisance mitrale.	151. Faux
152. L'intensité des pouls est abaissée à cause du reflux sanguin dans l'insuffisance aortique.	152. Faux

153. Le signe de Corrigan consiste en une diminution de l'intensité des pouls dans l'insuffisance aortique.	153. Faux
154. La PAD peut théoriquement s'abaisser jusqu'à 0mmHg dans l'insuffisance aortique mais est en réalité rarement <30mmHg.	154. Vrai
155. L'auscultation fémorale montre un pouls artériel normal dans l'insuffisance aortique.	155. Faux
156. Le B1 est souvent diminué à l'auscultation dans l'insuffisance aortique.	156. Vrai
157. Le B2 aortique est souvent absent à l'auscultation dans l'insuffisance aortique.	157. Vrai
158. La compression fémorale en amont du site de l'auscultation induit un double souffle crural en cas d'insuffisance aortique.	158. Vrai
159. L'auscultation d'une insuffisance aortique montre un flux diastolique décroissant régurgitant après le B1.	159. Faux
160. Le souffle d'insuffisance aortique est d'autant plus long que l'insuffisance est sévère.	160. Faux
161. Le B2 aortique est souvent augmenté en cas de sténose aortique car la valve est calcifiée.	161. Faux
162. L'auscultation d'une insuffisance aortique montre un flux diastolique croissant régurgitant après le B2.	162. Faux
163. La valve mitrale se ferme avant la systole ventriculaire en cas d'insuffisance aortique sévère.	163. Vrai
164. L'auscultation de l'insuffisance aortique montre un souffle parasternal gauche et un souffle dans le 2 ^{ème} espace intercostal droit.	164. Vrai

165. La pression artérielle systolique est très élevée dans l'insuffisance aortique.	165. Vrai
166. Le flux régurgitant de l'insuffisance aortique impacte la portion proximale de la branche gauche du faisceau de His et entraîne un bloc de branche gauche mineur à l'ECG.	166. Vrai
167. L'ECG montre une dilatation du VG avec altération de la repolarisation en cas d'insuffisance aortique.	167. Faux
168. La radiographie de thorax permet de mesurer la sévérité du reflux en cas d'insuffisance aortique.	168. Faux
169. L'échographie cardiaque est inutile dans le diagnostic de l'insuffisance aortique.	169. Faux
170. Le moment optimal pour proposer le remplacement valvulaire chirurgical en cas d'insuffisance aortique est au tout début des symptômes.	170. Faux
171. L'échographie permet de déterminer la sévérité du reflux, de rechercher une altération de la fonction ventriculaire et une augmentation du diamètre télésystolique du VG en cas d'insuffisance aortique.	171. Vrai
172. Le traitement de l'insuffisance aortique vise surtout à supprimer les symptômes.	172. Faux
173. Les bêtabloquants sont recommandés chez les patients atteints du syndrome de Marfan.	173. Vrai
174. La chirurgie valvulaire est recommandée pour tous les patients atteints d'insuffisance aortique.	174. Faux
175. La réparation de la valve aortique est possible dans certains cas d'insuffisance aortique.	175. Vrai
176. L'intervention de Bentall est utilisée pour remplacer l'aorte ascendante si elle est dilatée à >55mm.	176. Vrai

177. Les patients asymptomatiques ne doivent pas être opérés en cas d'insuffisance aortique.	177. Faux
178. Le remplacement valvulaire aortique chirurgical est nécessaire pour tous les patients présentant une insuffisance aortique aiguë.	178. Vrai
179. L'auscultation fémorale montre un double bruit systolique et diastolique (vibration de la paroi artérielle « en coup de fusil ») dans l'insuffisance mitrale.	179. Faux
180. L'insuffisance aortique peut être causée par la prise d'anorexigènes.	180. Vrai
181. Le traitement chirurgical de l'insuffisance cardiaque est indiqué pour les patients asymptomatiques qui présentent une altération de la fonction ventriculaire gauche même si leur capacité d'effort est normale.	181. Vrai
182. L'insuffisance cardiaque doit absolument être traitée en cas d'insuffisance aortique.	182. Vrai
183. Une aorte ascendante dilatée à <50mm chez un patient souffrant du syndrome de Marfan ou de bicuspidie aortique est une indication pour l'opération de Bentall.	183. Faux
184. Les patients asymptomatiques avec une augmentation du diamètre ventriculaire à l'échographie doivent être opérés rapidement en cas d'insuffisance aortique.	184. Vrai
185. Le remplacement valvulaire chirurgical n'est pas indiqué chez les patients symptomatiques atteints d'insuffisance aortique car la chirurgie n'améliore pas le pronostic.	185. Faux

186. Les patients avec une insuffisance aortique aiguë sont généralement asymptomatiques.	186. Faux
187. La dilatation auriculaire est un signe tardif d'insuffisance aortique.	187. Faux
188. La sténose mitrale résulte souvent d'une fusion des commissures.	188. Vrai
189. La sténose mitrale est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.	189. Vrai
190. Les 2 causes les plus fréquentes de sténose mitrale sont la dégénérescence de la valve et la radiothérapie thoracique.	190. Faux
191. La sténose mitrale peut rarement être causée par une tumeur carcinoïde pulmonaire.	191. Vrai
192. Les symptômes de sténose mitrale sont déclenchés par tous les événements qui ralentissent la fréquence cardiaque (grossesse, anémie, infection, exercice, thyrotoxicose,...).	192. Faux
193. La sténose mitrale est très souvent consécutive à un rhumatisme articulaire aigu.	193. Vrai
194. Les cas avancés de sténose mitrale peuvent provoquer une hypertension pulmonaire avec douleurs thoraciques et une insuffisance cardiaque droite avec œdèmes des membres inférieurs et hépatalgies.	194. Vrai
195. L'hypertension auriculaire gauche peut favoriser la fibrillation auriculaire et les thromboembolies.	195. Vrai
196. Le ralentissement du rythme cardiaque améliore les symptômes de la sténose mitrale par une augmentation de la durée de la systole et une meilleure vidange auriculaire.	196. Faux

197. L'ECG montre souvent une hypertrophie ventriculaire gauche dans la sténose mitrale.	197. Faux
198. La sténose mitrale peut entraîner une augmentation de la durée de l'onde P en D2.	198. Vrai
199. L'augmentation de pression dans l'oreillette droite secondaire à la sténose mitrale induit une dyspnée, un œdème pulmonaire hémodynamique et des hémoptysies.	199. Faux
200. La sténose mitrale se manifeste au début par de la dyspnée et une fatigue d'apparition progressive.	200. Vrai
201. La sténose mitrale peut se manifester par des symptômes aigus comme la FA et les embolies systémiques.	201. Vrai
202. La radiographie thoracique peut montrer une dilatation du ventricule droit dans la sténose mitrale.	202. Vrai
203. Dans la sténose mitrale, la valve mitrale est encore ouverte quand la systole ventriculaire débute.	203. Vrai
204. L'auscultation de la sténose mitrale montre un B2 claquant et un claquement d'ouverture mitral.	204. Faux
205. Le souffle de sténose mitrale est mieux perçu en décubitus dorsal et après l'exercice.	205. Faux
206. Le renforcement présystolique du souffle de sténose mitrale disparaît en cas de FA.	206. Vrai
207. L'auscultation d'une sténose mitrale montre un roulement holodiastolique avec un renforcement avant B1.	207. Vrai
208. Le P2 disparaît à l'auscultation en cas d'hypertension pulmonaire.	208. Faux
209. L'hypertrophie auriculaire gauche secondaire à la sténose mitrale se manifeste à l'ECG par une augmentation de la durée de l'onde P >0,08s en D2 et une augmentation de sa composante négative en V1.	209. Faux

210. La radiographie de thorax montre un double contour droit du cœur en cas de sténose mitrale.	210. Vrai
211. L'échographie cardiaque transthoracique est inutile dans le diagnostic de la sténose mitrale.	211. Faux
212. L'échographie cardiaque transoesophagienne permet de rechercher un thrombus dans l'auricule gauche avant une dilatation percutanée en cas de sténose mitrale.	212. Vrai
213. Le souffle de sténose mitrale est caractérisé par un renforcement présystolique dû à la contraction auriculaire gauche.	213. Vrai
214. Le cathétérisme cardiaque n'est pas indiqué en cas de sténose mitrale.	214. Faux
215. La commissurotomie percutanée permet de traiter une sténose mitrale par voie veineuse.	215. Vrai
216. Le traitement médical de l'insuffisance mitrale comprend une restriction hydrique et sodée.	216. Faux
217. La cardioversion électrique ou pharmacologique est parfois indiquée en cas de sténose mitrale.	217. Vrai
218. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués dans le traitement de la sténose mitrale.	218. Faux
219. Les anticoagulants directs sont recommandés pour les patients avec une fibrillation auriculaire et une sténose mitrale modérée à sévère.	219. Faux
220. La chirurgie de remplacement valvulaire mitral est la seule option pour traiter la sténose mitrale.	220. Faux
221. Les dihydropyridines sont indiquées dans le traitement de la sténose mitrale.	221. Faux

222. Le patient asymptomatique atteint de sténose mitrale doit être opéré si il présente une hypertension pré-capillaire pour éviter l'évolution vers une hypertension pulmonaire.	222. Faux
223. Les patients atteints de sténose mitrale ont un risque embolique très élevé.	223. Vrai
224. La sténose mitrale peut être asymptomatique.	224. Vrai
225. Un souffle holodiastolique au niveau du 2 ^e espace intercostal droit est un signe typique de sténose mitrale.	225. Faux
226. La sténose mitrale peut entraîner une insuffisance cardiaque droite.	226. Vrai
227. La digoxine est utilisée pour ralentir la fréquence cardiaque et la conduction auriculo-ventriculaire dans la sténose mitrale.	227. Vrai
228. L'hypertension pulmonaire est un signe fréquent de sténose tricuspide avancée.	228. Faux
229. Les symptômes de sténose mitrale peuvent être causés par une thyrotoxicose.	229. Vrai
230. La restriction hydrique et sodée est recommandée dans le traitement médical de la sténose mitrale.	230. Vrai
231. La dilatation ventriculaire gauche est un signe radiologique de sténose mitrale.	231. Faux
232. La commissurotomie percutanée est réservée aux patients âgés avec une sténose mitrale modérée.	232. Faux
233. L'épaississement de la paroi des capillaires pulmonaires est un signe de sténose mitrale avancée.	233. Vrai
234. L'hypertrophie auriculaire gauche est un signe électrocardiographique de sténose mitrale.	234. Vrai

235. Le traitement de la sténose mitrale vise à ralentir le rythme cardiaque et à traiter la fibrillation auriculaire.	235. Vrai
236. Les anticoagulants directs comme le dabigatran sont contre-indiqués en présence d'une FA et d'une sténose mitrale modérée à sévère.	236. Vrai
237. Les patients atteints de sténose mitrale et de FA doivent être traités avec un antagoniste de la vitamine K.	237. Vrai
238. La chirurgie de remplacement valvulaire mitrale est contre-indiquée en présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche.	238. Faux
239. Le remplacement valvulaire mitral utilise une valve mécanique si le patient à >70 ans.	239. Faux
240. La sténose mitrale peut être causée par une radiothérapie thoracique.	240. Vrai
241. La sténose mitrale peut être traitée par un « cathéter d'Inoue » dans certains cas pour séparer les commissures mitrales fusionnées.	241. Vrai
242. Le traitement médical de la sténose mitrale est à base de digoxine, de bêta-mimétiques ou de diltiazem.	242. Faux
243. Le traitement chirurgical de la sténose mitrale ne nécessite pas toujours un remplacement valvulaire.	243. Vrai
244. La commissurotomie percutanée nécessite de traverser le septum interauriculaire pour traiter la sténose mitrale.	244. Vrai
245. Tous les patients atteints de sténose mitrale nécessitent un traitement chirurgical.	245. Faux

246. La présence d'un thrombus dans l'oreillette gauche n'est pas une contre-indication à la commissurotomie mitrale percutanée.	246. Faux
247. La chirurgie est préférable à la commissurotomie percutanée si la valve mitrale sténosée est déformée ou calcifiée.	247. Vrai
248. Le remplacement valvulaire mitral utilise une valve biologique si le patient à >70 ans.	248. Vrai
249. L'insuffisance mitrale cause un flux anormal de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche.	249. Faux
250. L'insuffisance mitrale est la lésion valvulaire la plus prévalente.	250. Faux
251. La contraction des muscles papillaires empêche l'éversion valvulaire pendant la systole.	251. Vrai
252. La taille de l'anneau mitral augmente pendant la systole.	252. Faux
253. Une pathologie des cordages tendineux ou des muscles papillaires peut causer une insuffisance mitrale en absence de lésion valvulaire.	253. Vrai
254. Toute pathologie affectant les feuillets mitraux ou l'anneau mitral peut induire une régurgitation mitrale.	254. Vrai
255. La dégénérescence myxoïde ou « maladie de Marfan » est une cause fréquente d'insuffisance mitrale.	255. Faux
256. La radiothérapie thoracique peut causer une insuffisance mitrale par calcification de l'appareil valvulaire.	256. Vrai
257. Les cardiomyopathies ischémique ou dilatée peuvent induire une insuffisance mitrale.	257. Vrai

258.	Le rhumatisme articulaire aigu entraîne une rétraction des feuillets mitraux et un allongement des cordages.	258. Faux
259.	L'endocardite peut induire une destruction valvulaire et la rupture des cordages.	259. Vrai
260.	L'insuffisance mitrale entraîne une augmentation du volume téléstolique ventriculaire gauche.	260. Faux
261.	La fraction d'éjection ventriculaire gauche diminue dans l'insuffisance mitrale décompensée.	261. Faux
262.	L'insuffisance mitrale aiguë est caractérisée par une diminution du débit cardiaque.	262. Vrai
263.	La pression dans l'oreillette gauche diminue progressivement dans l'insuffisance mitrale chronique.	263. Vrai
264.	L'insuffisance mitrale aiguë induit une congestion pulmonaire avec orthopnée, fatigue et dyspnée à l'effort.	264. Vrai
265.	L'insuffisance mitrale aiguë est généralement bien tolérée car l'oreillette saine est très compliant.	265. Faux
266.	La pression dans la circulation pulmonaire augmente progressivement en cas d'insuffisance mitrale.	266. Faux
267.	Le volume télédiastolique ventriculaire gauche augmente en cas d'insuffisance mitrale.	267. Vrai
268.	Le B3 est souvent présent en fin de diastole à l'auscultation dans l'insuffisance mitrale.	268. Faux
269.	La compliance ventriculaire diminue dans les formes chroniques d'insuffisance mitrale.	269. Faux
270.	En cas d'insuffisance mitrale, la dyspnée est provoquée par une augmentation de pression dans les cavités cardiaques droites.	270. Faux
271.	Un 3 ^{ème} bruit cardiaque est souvent entendu à l'auscultation d'une sténose mitrale.	271. Faux

272. La dilatation ventriculaire aggrave l'insuffisance mitrale par dilatation de l'anneau valvulaire.	272. Vrai
273. Le ventricule se dilate et la paroi ventriculaire s'épaissit en cas d'insuffisance mitrale pour permettre un remplissage accru sans augmentation de la pression ventriculaire.	273. Faux
274. L'insuffisance mitrale chronique peut rester longtemps asymptomatique.	274. Vrai
275. Une fraction d'éjection du VG normale est un signe de gravité en cas d'insuffisance mitrale.	275. Vrai
276. La décompensation cardiaque est favorisée par une nécrose myofibrillaire dans l'insuffisance mitrale.	276. Vrai
277. La décompensation cardiaque est favorisée par une altération du métabolisme sodique dans l'insuffisance mitrale.	277. Faux
278. L'insuffisance mitrale peut présenter des formes aiguës et chroniques compensées ou décompensées.	278. Vrai
279. La diminution ou la disparition du souffle est un signe de gravité dans l'insuffisance mitrale aigue.	279. Vrai
280. En cas d'insuffisance mitrale, la fraction d'éjection du ventricule gauche augmente car le ventricule éjecte aisément dans l'oreillette gauche à basse pression au lieu d'éjecter dans l'aorte à haute pression.	280. Vrai
281. Le B1 est augmenté en cas d'insuffisance mitrale aigue.	281. Faux
282. L'insuffisance mitrale chronique se manifeste par un souffle holosystolique à l'apex irradié dans les carotides.	282. Faux

283. L'insuffisance mitrale chronique se manifeste par de la fatigue, des signes de bas débit cardiaque et une insuffisance cardiaque gauche dans les formes avancées.	283. Faux
284. L'insuffisance mitrale chronique peut se manifester par des signes d'hypertension pulmonaire avec un P2 claquant à l'auscultation.	284. Vrai
285. L'insuffisance mitrale prédispose à la fibrillation auriculaire et aux embolies.	285. Vrai
286. Le souffle d'insuffisance mitrale commence après le B1 et s'arrête avant le B2.	286. Faux
287. L'ECG montre une hypertrophie des cavités gauches et une FA en cas d'insuffisance mitrale.	287. Vrai
288. La radiographie de thorax permet de visualiser la congestion pulmonaire en cas d'insuffisance mitrale.	288. Vrai
289. L'échographie cardiaque externe permet de visualiser la valve mitrale mais pas l'appareil sous-valvulaire.	289. Faux
290. La radiographie de thorax permet de visualiser des végétations mitrales en cas d'endocardite.	290. Faux
291. Le cathétérisme cardiaque est utilisé pour faire des mesures hémodynamiques en cas d'insuffisance mitrale et surtout pour confirmer une hypertension pulmonaire.	291. Vrai
292. Les diurétiques sont utilisés dans le traitement de l'insuffisance mitrale aigue pour diminuer la stase pulmonaire et la tension artérielle.	292. Vrai
293. Une insuffisance mitrale aigue avec hypotension artérielle nécessite une chirurgie urgente.	293. Vrai

294. Le traitement de l'insuffisance mitrale aigue consiste à diminuer les résistances vasculaires centrales avec des vasodilatateurs pour favoriser le flux vers l'aorte.	294. Faux
295. Le nitroprussiate est un antihypertenseur puissant utilisé dans le traitement de l'insuffisance mitrale aigue.	295. Vrai
296. Le B3 est un bruit cardiaque supplémentaire entendu en début de diastole, juste après la fermeture des valves aortique et pulmonaire.	296. Vrai
297. Toutes les insuffisances mitrale aigues doivent être opérées même si elle n'entraîne pas de troubles hémodynamiques significatifs pour éviter l'évolution vers une forme chronique.	297. Faux
298. Le remplacement valvulaire mitral est la seule option chirurgicale pour l'insuffisance mitrale.	298. Faux
299. Le patient asymptomatique atteint d'insuffisance mitrale chronique doit être opéré si la fraction d'éjection ventriculaire droite diminue.	299. Vrai
300. La chirurgie est indiquée pour tous les patients symptomatiques atteints d'insuffisance mitrale importante.	300. Vrai
301. La fibrillation auriculaire est une contre-indication à la chirurgie en cas d'insuffisance mitrale.	301. Faux
302. La chirurgie est indiquée si le diamètre télésystolique du VG augmente en cas d'insuffisance mitrale.	302. Vrai
303. La chirurgie est indiquée si la PA diastolique pulmonaire augmente en cas d'insuffisance mitrale.	303. Faux
304. L'annuloplastie est une option de traitement pour la sténose mitrale.	304. Faux

305. L'annuloplastie est une opération qui consiste à suturer les commissures des feuillets valvulaires mitraux.	305. Faux
306. Le remplacement valvulaire mitral est préférable à l'annuloplastie s'il y a une forte probabilité de succès à long terme dans le traitement de l'insuffisance mitrale.	306. Faux
307. La maladie de Barlow est responsable d'un prolapsus mitral en milieu de systole.	307. Vrai
308. En cas d'insuffisance mitrale, le débit cardiaque aortique chute alors que la FEVG est augmentée.	308. Vrai
309. Le remplacement valvulaire mitral est la seule option chirurgicale pour l'insuffisance mitrale.	309. Faux
310. L'échographie cardiaque peut montrer une valve mitrale épaissie dans l'insuffisance mitrale.	310. Vrai
311. La régurgitation aiguë de l'insuffisance mitrale est souvent traitée par réduction de la RVP.	311. Vrai
312. La réparation valvulaire mitrale est préférable au remplacement valvulaire pour préserver la fonction ventriculaire en cas d'insuffisance mitrale.	312. Vrai
313. La réparation valvulaire mitrale nécessite une anticoagulation par aspirine pendant 3 mois.	313. Faux
314. La prothèse valvulaire mitrale mécanique nécessite une anticoagulation par AVK à vie.	314. Vrai
315. L'échographie peut aider le chirurgien à choisir la technique chirurgicale pour l'insuffisance mitrale.	315. Vrai
316. La réparation valvulaire mitrale avec annuloplastie est indiquée pour les valves calcifiées.	316. Faux
317. Les cordages sous-valvulaires sont préservés lors d'une annuloplastie.	317. Vrai

318.	Le remplacement vasculaire mitral est préférable à l'annuloplastie en cas de prolapsus mitral étendu.	318. Vrai
319.	L'annuloplastie consiste à suturer un anneau souple afin de rétrécir l'anneau valvulaire mitral.	319. Faux
320.	La valve mitrale réparée ne nécessite pas d'anticoagulation à long terme.	320. Vrai
321.	La réparation valvulaire est préférable au remplacement valvulaire pour préserver la fonction ventriculaire.	321. Vrai
322.	L'insuffisance mitrale cause un flux anormal du ventricule gauche vers l'oreillette gauche durant la systole.	322. Vrai
323.	L'annuloplastie est réservée aux patients jeunes asymptomatiques.	323. Faux
324.	Les formes aiguës d'insuffisance mitrale provoquent une élévation de la pression dans l'oreillette gauche.	324. Vrai
325.	La chirurgie classique doit être évitée tant que possible dans le traitement de l'insuffisance mitrale.	325. Vrai
326.	La réparation de la valve mitrale par annuloplastie nécessite une courte anticoagulation par antivitamines K.	326. Vrai
327.	La tension pariétale du ventricule gauche diminue dans l'insuffisance mitrale.	327. Faux
328.	Le remplacement valvulaire mitral par une bioprothèse nécessite une anticoagulation de 3 mois par AVK.	328. Vrai
329.	Les anticoagulants directs sont recommandés en cas de FA après pose d'une valve mitrale biologique.	329. Vrai
330.	L'insuffisance mitrale peut être associée au syndrome de Marfan et à la maladie de Horton.	330. Faux
331.	La fibrillation auriculaire est peu fréquente dans l'insuffisance mitrale.	331. Faux
332.	La section des cordages valvulaires lors du remplacement valvulaire mitral altère la fonction auriculaire.	332. Faux

333. La chirurgie de remplacement valvulaire mitrale sans préservation de l'appareil sous-valvulaire est à éviter.	333. Vrai
334. La maladie de Barlow affecte environ 2% des adultes.	334. Vrai
335. La transmission génétique du prolapsus valvulaire mitral est de type autosomique récessif.	335. Faux
336. La maladie de Barlow est caractérisée par une rétraction des cordages sous-valvulaires.	336. Faux
337. Les valves mitrales sont élargies et raccourcies dans le prolapsus valvulaire mitral.	337. Faux
338. La régurgitation mitrale dans le prolapsus valvulaire mitral résulte de l'éversion valvulaire dans le VG.	338. Faux
339. La maladie de Barlow débute entre 10 et 16 ans.	339. Vrai
340. Le prolapsus valvulaire mitral affecte plus souvent le feuillet mitral antérieur que le feuillet postérieur.	340. Faux
341. Le prolapsus valvulaire mitral peut être accompagné de légères scolioses et d'un pectus carinatum.	341. Faux
342. Le prolapsus valvulaire mitral est souvent asymptomatique.	342. Vrai
343. Le click mésosystolique est un signe typique du prolapsus valvulaire mitral.	343. Vrai
344. Le souffle du prolapsus valvulaire mitral est mieux entendu en décubitus latéral gauche ou assis.	344. Vrai
345. La maladie de Barlow cause des anomalies du tissu conjonctif et le collagène valvulaire est fragmenté.	345. Vrai
346. La maladie de Barlow est caractérisée par un souffle mésosystolique à l'apex.	346. Faux
347. Le souffle de prolapsus mitral continue jusqu'au B2 et le recouvre.	347. Vrai

348. L'échographie cardiaque est inutile dans le diagnostic du prolapsus valvulaire mitral.	348. Faux
349. L'hypertension artérielle légère doit être traitée en cas de prolapsus valvulaire mitral.	349. Vrai
350. La réparation valvulaire est le seul traitement curatif du prolapsus valvulaire mitral.	350. Vrai
351. Le prolapsus valvulaire mitral peut être diagnostiqué par un souffle télésystolique.	351. Vrai
352. La dilatation ventriculaire dans l'insuffisance cardiaque entraîne une dilatation de l'anneau mitral.	352. Vrai
353. La fibrillation auriculaire peut être responsable d'insuffisance mitrale sans dilatation importante du VG.	353. Vrai
354. La régurgitation mitrale atténue la surcharge en volume de l'insuffisance cardiaque.	354. Faux
355. Le souffle holosystolique à l'apex est un signe caractéristique de l'insuffisance mitrale.	355. Vrai
356. L'échographie et le scanner thoracique sont utilisés pour diagnostiquer les cardiopathies dilatées avec insuffisance mitrale secondaire.	356. Faux
357. À la radiographie thoracique, une cardiomégalie est typique de l'insuffisance cardiaque.	357. Vrai
358. Le traitement de l'insuffisance cardiaque inclut différents médicaments à la dose minimale efficace.	358. Faux
359. Une réparation mitrale peut être envisagée si le patient reste symptomatique malgré un traitement médical maximal.	359. Vrai
360. L'implantation percutanée d'un clip mitral est réservée aux patients dont le VG est sévèrement dilaté.	360. Faux

361. La réparation mitrale par annuloplastie est le traitement de 1 ^{ère} intention pour les cas d'insuffisance mitrale secondaire à une insuffisance cardiaque.	361. Faux
362. L'implantation percutanée d'un clip mitral est une option pour les patients inopérables présentant une insuffisance mitrale sévère.	362. Vrai
363. La régurgitation mitrale contribue à la progression de l'insuffisance cardiaque par la surcharge en volume.	363. Vrai
364. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque comprennent souvent une dyspnée et une toux persistante.	364. Faux
365. L'implantation percutanée d'un clip sert à solidariser la partie centrale des 2 feuillets mitraux.	365. Vrai
366. L'insuffisance tricuspide est plus souvent congénitale que secondaire à d'autres affections cardiaques.	366. Faux
367. L'insuffisance tricuspide peut être due à la surcharge volémique induite par un shunt intracardiaque.	367. Vrai
368. La dilatation ventriculaire droite peut contribuer à l'induction de l'insuffisance mitrale.	368. Faux
369. Les muscles papillaires sont présents uniquement dans le ventricule gauche.	369. Faux
370. L'endocardite est une cause rare d'insuffisance tricuspide associée à la toxicomanie par voie intraveineuse.	370. Vrai
371. La maladie d'Ebstein est caractérisée par une implantation trop haute de la valve tricuspide.	371. Faux
372. L'insuffisance tricuspide est généralement secondaire à une hypertension pulmonaire due à une pathologie du cœur droit ou de la valve pulmonaire.	372. Faux

373.	La maladie d'Ebstein est caractérisée par une « atrialisation » d'une partie du ventricule droit.	373. Vrai
374.	L'ascite, les œdèmes périphériques et l'hépatomégalie sont des symptômes de l'insuffisance tricuspide.	374. Vrai
375.	La durée de l'onde P est augmentée en cas d'insuffisance tricuspide.	375. Faux
376.	L'ECG dans l'insuffisance tricuspide révèle généralement une hypertrophie auriculaire gauche.	376. Faux
377.	L'hypertrophie auriculaire droite est caractérisée par des ondes P pointues >5mm en D2, D3 et aVF à l'ECG.	377. Faux
378.	La cardiomégalie peut être observée à la radiographie thoracique en cas d'insuffisance tricuspide.	378. Vrai
379.	L'axe du complexe QRS n'est pas dévié en cas d'hypertrophie ventriculaire droite.	379. Faux
380.	La durée de l'onde P est augmentée en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche.	380. Faux
381.	L'échographie cardiaque permet de diagnostiquer une insuffisance tricuspide.	381. Vrai
382.	L'insuffisance tricuspide est caractérisée par un souffle holosystolique parasternal droit.	382. Faux
383.	Le B2 est atténué en cas d'hypertension aortique.	383. Faux
384.	Le rhumatisme articulaire aigu n'affecte jamais les valves du cœur droit.	384. Faux
385.	La radiographie montre souvent une altération du parenchyme pulmonaire en cas d'insuffisance tricuspide.	385. Vrai
386.	Le traitement de l'insuffisance tricuspide comprend des diurétiques pour réduire l'ascite et les œdèmes.	386. Vrai
387.	L'annuloplastie ou la réparation tricuspide est une option de traitement pour l'insuffisance tricuspide.	387. Vrai

388.	L'hypertrophie auriculaire gauche est caractérisée par des ondes P >2,5mm en D2, D3 et aVF.	388. Faux
389.	La projection de la valve tricuspide sur le thorax est du côté gauche du sternum.	389. Vrai
390.	L'annuloplastie tricuspide nécessite 3 mois d'anticoagulation par antivitamines K.	390. Vrai
391.	Le souffle holosystolique parasternal gauche est un signe de sténose tricuspide.	391. Faux
392.	Le souffle de sténose tricuspide diminue à l'inspiration à cause d'une diminution du retour veineux.	392. Faux
393.	La sténose pulmonaire touche principalement les enfants.	393. Vrai
394.	La sténose tricuspide est caractérisée par un roulement diastolique parasternal gauche.	394. Vrai
395.	La valvuloplastie par ballonnet est envisagée si le traitement de la sténose tricuspide par des diurétiques est insuffisant.	395. Vrai
396.	La surcharge volémique peut induire une sténose tricuspide.	396. Faux
397.	L'ECG dans la sténose tricuspide révèle généralement une hypertrophie auriculaire droite.	397. Vrai
398.	La sténose tricuspide est généralement associée à un rhumatisme articulaire.	398. Vrai
399.	La régurgitation tricuspide est souvent associée à une hypertension pulmonaire.	399. Vrai
400.	La sténose tricuspide est souvent due à une endocardite droite associée à la toxicomanie intraveineuse.	400. Faux
401.	L'ascite est rarement observée chez les patients atteints de sténose tricuspide.	401. Faux

402. La sténose pulmonaire est une affection rare chez les adultes.	402. Vrai
403. Le syndrome carcinoïde est caractérisé par la production de substance P par des métastases hépatiques avec une inflammation et une sténose de la valve tricuspide.	403. Faux
404. L'endocardite infectieuses est 2x plus fréquente chez les hommes.	404. Vrai
405. L'incidence de l'endocardite diminue avec l'âge car les angines à Strepto A surviennent dans l'enfance.	405. Faux
406. L'endocardite affecte le cœur gauche dans 85% des cas (plus souvent la valve mitrale que l'aortique).	406. Faux
407. Les végétations composées de fibrine, de globules rouges, de cellules inflammatoires et d'agrégats de microorganismes peuvent s'étendre dans les cavités cardiaques.	407. Faux
408. Les végétations peuvent emboliser dans plusieurs organes, y compris les reins, la rate, le foie et le cerveau.	408. Vrai
409. Les enzymes protéolytiques des germes peuvent provoquer des ruptures de cordage en cas d'endocardite.	409. Vrai
410. Les végétations infectieuses sont responsables de déchirures, d'ulcérations et de perforations valvulaires.	410. Vrai
411. Les abcès cardiaques sont souvent limités à l'anneau valvulaire en cas d'endocardite.	411. Faux
412. Les abcès cardiaques peuvent induire une fistule entre les ventricules ou entre les cavités gauches.	412. Faux
413. Les anévrismes mycotiques sont toujours induits par une invasion directe de la paroi artérielle.	413. Faux
414. Les anévrismes mycotiques peuvent se former dans les artères cérébrales et les artères mésentériques.	414. Vrai

415.	Les anévrismes mycotiques surviennent souvent dans le sinus de Valsalva.	415. Vrai
416.	La myocardite est une complication fréquente de l'endocardite infectieuse.	416. Faux
417.	Un embole septique peut provoquer un infarctus myocardique en cas d'endocardite.	417. Vrai
418.	L'endocardite aortique peut se compliquer d'une péricardite infectieuse.	418. Vrai
419.	L'endocardite infectieuse survient généralement sur une structure endocardique saine.	419. Faux
420.	Les lésions endothéliales sont initialement stériles mais peuvent être colonisées par des bactéries.	420. Vrai
421.	Les lésions endothéliales se forment principalement sur le versant ventriculaire gauche de la valve mitrale.	421. Faux
422.	Les végétations infectées embolisent le plus souvent dans les poumons.	422. Faux
423.	L'endothélium sain résiste à la greffe microbienne.	423. Vrai
424.	L'endocardite peut survenir même en l'absence de lésion cardiaque préexistante.	424. Vrai
425.	Les turbulences engendrées par un shunt cardiaque favorisent les endocardites en cas de bactériémie.	425. Vrai
426.	L'endocardite survient sur le versant ventriculaire gauche d'une communication inter-ventriculaire.	426. Faux
427.	Les végétations infectieuses embolisent chez la majorité des patients.	427. Faux
428.	Les végétations infectieuses sont souvent vascularisées, ce qui protège les germes contre l'immunité.	428. Faux
429.	L'endocardite peut entraîner des désinsertions complètes de prothèses valvulaires.	429. Vrai

430. Les abcès para-valvulaires peuvent provoquer des métastases infectieuses à distance en cas d'endocardite.	430. Vrai
431. L'immunité humorale est efficace contre les végétations infectieuses mais pas l'immunité cellulaire.	431. Faux
432. L'endocardite infectieuse provoque une immunosuppression généralisée.	432. Faux
433. Le TAVI présente un risque d'endocardite moins élevé que les valves prothétiques.	433. Faux
434. Un risque augmenté d'endocardite persiste durant les 6 premiers mois après l'intervention correctrice en cas de pathologie congénitale non cyanogène.	434. Vrai
435. Les patients avec un antécédent d'endocardite sont à haut risque de refaire une endocardite.	435. Vrai
436. Les interventions dentaires sont une source courante d'infection pour les endocardites.	436. Vrai
437. Les streptocoques viridans sont responsables des endocardites associées à des interventions digestives.	437. Faux
438. Les staphylocoques sont rarement associés aux infections cardiaques après des interventions dentaires.	438. Vrai
439. Les entérocoques et certains bacilles Gram- peuvent provoquer des endocardites sur valve native.	439. Vrai
440. Les symptômes d'endocardite surviennent généralement dans les 7 jours suivant la bactériémie.	440. Faux
441. La fièvre de l'endocardite subaiguë est absente chez le sujet âgé ou en cas d'insuffisance rénale chronique.	441. Vrai
442. L'endocardite est toujours mortelle en l'absence de traitement.	442. Vrai
443. L'érythème de Janeway est caractérisée par des lésions palmo-plantaires douloureuses.	443. Faux

444. Le faux panaris d'Osler est caractérisé par des nodules sous-cutanés rouge-bleutés non douloureux sur les doigts et les orteils.	444. Faux
445. Les tâches de Roth sont des hémorragies rétinienne à centre foncé visibles au fond d'œil.	445. Faux
446. L'endocardite subaiguë provoque une pyrexie fluctuante et persistante <39°C.	446. Vrai
447. Les embolies septiques provoquent des pétéchies buccales, conjonctivales et sur les extrémités et de petites hémorragies sous-unguéales en cas d'endocardite.	447. Vrai
448. L'endocardite cause une glomérulonéphrite avec insuffisance rénale chronique, hématurie et protéinurie.	448. Faux
449. Le souffle de régurgitation valvulaire diminue à cause des végétations en cas d'endocardite subaiguë.	449. Faux
450. L'endocardite subaiguë peut provoquer une splénomégalie et un syndrome grippal.	450. Vrai
451. L'endocardite subaiguë est due à un germe virulent comme le staphylocoque doré ou le pseudomonas.	451. Faux
452. L'échographie permet de différencier des végétations infectieuses, anciennes et non infectieuses.	452. Faux
453. Le risque emboligène est accru quand les végétations infectieuses mesurent >5mm.	453. Faux
454. L'endocardite aiguë se manifeste par un début brutal, une T° <39°C, des frissons, une splénomégalie et un purpura nécrotique.	454. Faux
455. La destruction valvulaire induit l'apparition rapide d'un souffle en cas d'endocardite aiguë.	455. Vrai

456. L'échographie cardiaque est le 1 ^{er} examen à réaliser aux urgences en cas d'endocardite aigue.	456. Faux
457. L'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire à l'ECG doit faire suspecter un abcès de l'anneau mitral en cas d'endocardite aigue.	457. Faux
458. L'échographie transoesophagienne est plus sensible que l'échographie externe pour le diagnostic de l'endocardite, surtout en cas de valve prothétique, et pour la recherche de complications.	458. Vrai
459. Un ECG est à réaliser dès l'admission aux urgences en cas d'endocardite aigue.	459. Vrai
460. Les hémocultures se réalisent préférentiellement sur un prélèvement artériel en cas d'endocardite.	460. Faux
461. Il ne faut pas attendre le pic thermique ou les frissons pour réaliser des hémocultures en cas de suspicion d'endocardite.	461. Vrai
462. Les tests sérologiques sont parfois nécessaires pour détecter les germes rares responsables d'endocardite.	462. Vrai
463. Les symptômes de l'endocardite apparaissent généralement dans les 24 heures suivant l'infection.	463. Faux
464. Les hémocultures sont généralement négatives lorsque le patient a déjà reçu un traitement antibiotique.	464. Vrai
465. Les antibiotiques doivent être bactériostatiques dans la végétation pour traiter efficacement l'endocardite.	465. Faux
466. La disparition de la fièvre est un indicateur fiable de la réponse au traitement antibiotique.	466. Vrai
467. Les végétations infectieuses ne disparaissent que dans 40% des cas après le traitement d'une endocardite.	467. Vrai

468. Les végétations infectieuses disparaissent généralement complètement avec le traitement antibiotique.	468. Faux
469. La chirurgie n'est pas recommandée pour les patients atteints d'endocardite infectieuse.	469. Faux
470. Il faut toujours attendre la désinfection par antibiotiques avant d'opérer une endocardite.	470. Faux
471. L'antibioprophylaxie est recommandée avant toute intervention dentaire chez les patients à haut risque d'endocardite.	471. Vrai
472. Un traitement dentaire est nécessaire avant tout remplacement valvulaire.	472. Vrai
473. L'endocardite s'accompagne de modifications de la biologie sanguine : élévation de la CRP, anémie monochrome normocytaire, leucocytose, hyperplaquettose, hypocomplémentarité,...	473. Faux
474. 2g d'ampicilline sont administrés en IV une heure avant une chirurgie ORL chez les patients à haut risque d'endocardite.	474. Faux
475. L'antibioprophylaxie est recommandée avant une chirurgie orthopédique chez les patients à haut risque d'endocardite.	475. Faux
476. Tous les prélèvements bactériologiques doivent être effectués avant de débiter les antibiotiques en cas de suspicion d'endocardite infectieuse.	476. Vrai
477. L'endocardite infectieuse est traitée par des antibiotiques per os pour une longue durée.	477. Faux

478.	La réponse au traitement antibiotique est souvent rapide en cas d'endocardite et la fièvre disparaît en 24h.	478. Faux
479.	Les antivitamines K doivent être stoppés dans le traitement de l'endocardite.	479. Vrai
480.	Une fièvre prolongée en cas d'endocardite traitée doit faire suspecter un foyer extra-cardiaque ou un abcès.	480. Vrai
481.	Les paramètres inflammatoires se normalisent en plusieurs semaines après une endocardite traitée.	481. Vrai
482.	Le traitement chirurgical de l'endocardite réduit la durée de l'antibiothérapie.	482. Faux
483.	L'endocardite sur valve prothétique doit être opérée si elle est due à <i>Streptococcus viridans</i> .	483. Faux
484.	L'endocardite mycotique est une indication chirurgicale même sur valve native.	484. Vrai
485.	Le traitement chirurgical est indiqué dans de nombreux cas d'endocardite : insuffisance cardiaque sur dysfonction valvulaire, sepsis prolongé, embolies récurrentes, abcès, fistules, récurrences tardives,...	485. Faux
486.	Le remplacement valvulaire par une valve mécanique est préférable après une endocardite.	486. Faux
487.	L'endocardite est une affection sévère qui cause environ 25% de mortalité	487. Vrai
488.	La chirurgie valvulaire doit parfois être retardée en cas d'infarctus myocardique récent.	488. Faux
489.	Les valves sont souvent trop abîmées pour être réparées après une endocardite infectieuse.	489. Faux
490.	L'endocardite valvulaire droite atteint 5x plus les hommes que les femmes, de préférence avant 40 ans.	490. Vrai
491.	Les antivitamines K doivent être remplacées par de l'héparine en cas d'endocardite infectieuse.	491. Vrai

492. L'endocardite valvulaire droite est le plus souvent causée par des streptocoques.	492. Faux
493. L'endocardite valvulaire droite touche le plus souvent la valve pulmonaire.	493. Faux
494. Les endocardites prothétiques précoces surviennent <60 jours après l'opération.	494. Vrai
495. Les endocardites prothétiques tardives sont souvent causées par des staphylocoques.	495. Faux
496. Les anévrismes mycotiques cérébraux sont responsables d'hémorragies cérébrales parfois des années après l'infection.	496. Vrai
497. L'AVC chez le sujet jeune qui présente de la fièvre doit faire suspecter une endocardite.	497. Vrai
498. Les endocardites compliquées peuvent entraîner des embolies coronaires.	498. Vrai
499. Les endocardites non infectieuses peuvent être causées par des traumatismes cardiaques.	499. Vrai
500. Les endocardites valvulaires droites surviennent principalement chez les personnes âgées.	500. Faux
501. Les endocardites infectieuses sont associées à une hypercoagulabilité ou à des néoplasies.	501. Faux
502. Les endocardites valvulaires droites peuvent causer des embolies pulmonaires.	502. Vrai
503. Les endocardites non infectieuses peuvent être causées par des complexes immuns circulants.	503. Vrai
504. Les endocardites droites sont souvent associées à une consommation de drogues intraveineuses.	504. Vrai
505. Les abcès annulaires sont caractéristiques des endocardites sur valves prothétiques.	505. Vrai

506. Les endocardites sur valves prothétiques sont toujours aiguës.	506. Faux
507. La communication inter-auriculaire est responsable d'un passage sanguin pathologique de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche.	507. Faux
508. La communication est généralement située dans la portion latérale du septum inter-auriculaire.	508. Faux
509. Les communications inter-auriculaires sont deux fois plus fréquentes chez les femmes.	509. Vrai
510. La communication inter-auriculaire représente 30% des anomalies congénitales cardiaques.	510. Faux
511. Le diagnostic de la communication inter-auriculaire est souvent fait à l'âge adulte.	511. Vrai
512. La communication inter-auriculaire est généralement familiale.	512. Faux
513. Un foramen ovale perméable est une communication inter-ventriculaire normale dans la vie fœtale.	513. Faux
514. Le foramen ovale perméable reste perméable chez 30 % des adultes.	514. Vrai
515. La pression auriculaire gauche plus élevée collabe les deux feuillets du foramen ovale perméable donc le shunt gauche-droit est généralement faible.	515. Vrai
516. L'élévation de la pression auriculaire droite augmente le risque d'embolie paradoxale.	516. Vrai
517. L'embolie paradoxale est caractérisée par le passage d'un thrombus ou de bulles d'air à travers le foramen ovale perméable de la circulation systémique vers la circulation veineuse.	517. Faux

518. La communication de type ostium secundum est moins fréquente que le foramen ovale perméable.	518. Faux
519. Les communications inter-auriculaires situées plus antérieures sont dues à un ostium secundum.	519. Faux
520. L'ostium secundum représente 70% des communications inter-auriculaires.	520. Vrai
521. L'ostium primum est souvent associé à une fente dans le feuillet mitral postérieur.	521. Faux
522. Les communications de type "sinus veineux" sont associées à une communication anormale entre l'oreillette droite et la veine pulmonaire droite.	522. Vrai
523. Les communications inter-auriculaires de type "sinus veineux inférieur" sont rarement associées à une connexion biauriculaire à la veine cave supérieure.	523. Faux
524. Les communications inter-auriculaires de type "sinus veineux supérieur" peuvent être associées à un abouchement anormal des veines pulmonaires dans l'oreillette droite ou dans la VCS.	524. Vrai
525. Le sens du shunt à travers la communication inter-auriculaire dépend de la pression intra-auriculaire qui dépend elle-même de la compliance ventriculaire.	525. Vrai
526. La dilatation des cavités droites est caractéristique d'une communication inter-auriculaire large.	526. Vrai
527. Moins de 10 % des patients développent une hypertension artérielle pulmonaire chronique suite à une CIA.	527. Vrai
528. L'oreillette gauche est souvent dilatée dans les cas de communication inter-auriculaire.	528. Faux

529. Le ventricule droit est naturellement plus compliant que le ventricule gauche.	529. Vrai
530. La pression est de l'ordre de 0 mmHg dans l'oreillette gauche et de 5 mmHg dans l'oreillette droite.	530. Faux
531. Dans les cas sévères de communication inter-auriculaires, l'entièreté de l'arbre vasculaire pulmonaire peut être dilaté et comprimer les bronches.	531. Vrai
532. Les patients atteints de communication inter-auriculaire sont souvent asymptomatiques.	532. Vrai
533. Un dédoublement large et fixe de B2 (P2 retardé) est caractéristique de la communication inter-auriculaire.	533. Vrai
534. Les communications inter-auriculaire sont trop faibles pour induire un souffle à l'auscultation.	534. Faux
535. L'hypertension artérielle pulmonaire survient dans les cas avancés de CIA car il faut que la pression auriculaire droite augmente et inverse le shunt pour augmenter la pression vasculaire pulmonaire.	535. Vrai
536. L'éjection auriculaire droite est retardée à cause de la surcharge en volume en cas de CIA.	536. Faux
537. L'auscultation d'une CIA montre 2 souffles éjectionnels : un souffle systolique pulmonaire au bord latéral gauche du sternum et un souffle diastolique tricuspide au 2 ^{ème} espace intercostal droit.	537. Faux
538. La radiographie de thorax montre une dilatation auriculaire droite et des artères pulmonaires dilatées en cas de communication inter-auriculaire.	538. Vrai
539. L'ECG montre fréquemment des blocs de branche en cas de communication inter-auriculaire.	539. Vrai

540. La communication inter-auriculaire peut se manifester par de la FA à l'ECG.	540. Vrai
541. L'échographie cardiaque externe ne permet pas diagnostiquer une communication inter-auriculaire.	541. Faux
542. Le cathétérisme cardiaque est utile pour quantifier le shunt en cas de communication inter-auriculaire.	542. Vrai
543. La fermeture percutanée est recommandée pour les CIA de type ostium secundum.	543. Vrai
544. La communication inter-auriculaire doit être fermée si le débit pulmonaire droit est 2x plus important que le débit aortique et si le patient est symptomatique.	544. Faux
545. La fermeture percutanée est indiquée en cas de communication inter-auriculaire de type ostium primum.	545. Faux
546. La résistance pulmonaire élevée contre-indique la fermeture d'une communication inter-auriculaire.	546. Vrai
547. Un souffle diastolique pulmonaire est caractéristique de la communication inter-auriculaire à l'auscultation.	547. Faux
548. La fermeture chirurgicale est la seule option de traitement pour les communications inter-auriculaires de type ostium secundum.	548. Faux
549. Le syndrome d'Eisenmenger est une indication à la fermeture chirurgicale ou percutanée d'une CIA.	549. Faux
550. La communication inter-ventriculaire est responsable d'un passage de sang du ventricule gauche vers le ventricule droit.	550. Vrai
551. La maladie de Roger est causée par une anomalie chromosomique.	551. Faux

552.	80% des CIV sont situées dans le septum membraneux, directement sous la valve aortique.	552. Vrai
553.	La communication inter-ventriculaire représente 10% des affections cardiaques congénitales.	553. Faux
554.	La plupart des communications inter-ventriculaires sont situées dans le septum musculaire.	554. Faux
555.	La résistance pulmonaire diminue à la naissance.	555. Vrai
556.	Les communications inter-ventriculaires ne sont jamais localisées dans la chambre de chasse ventriculaire.	556. Faux
557.	Un shunt inter-ventriculaire gauche-droit surcharge principalement le ventricule droit.	557. Vrai
558.	Un shunt inter-ventriculaire peut induire une hypertension artérielle pulmonaire.	558. Vrai
559.	Les shunts de petite taille sont souvent diagnostiqués à l'âge adulte.	559. Vrai
560.	L'orifice congénital dans le septum interventriculaire résulte d'une interaction entre une prédisposition génétique et des facteurs environnementaux.	560. Vrai
561.	Les communications inter-ventriculaires sont des affections congénitales cyanogènes.	561. Faux
562.	La dilatation cardiaque peut induire des atélectasies par compression des voies respiratoires en cas de CIV.	562. Vrai
563.	La communication inter-ventriculaire est surtout une affection pédiatrique.	563. Vrai
564.	L'ECG est généralement normal en cas de communication inter-ventriculaire.	564. Vrai
565.	Une communication inter-ventriculaire entraîne un souffle holodiastolique qui recouvre souvent le B2.	565. Faux

566. La fermeture spontanée des petites communications inter-ventriculaires se produit généralement au cours des 2 premières années de vie.	566. Vrai
567. La communication inter-ventriculaire découverte à l'âge adulte a un mauvais pronostic à long terme.	567. Faux
568. Les communications inter-ventriculaires découvertes à l'âge adulte ne présentent aucun risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire et ne doivent pas être opérées.	568. Vrai
569. Un rapport des débits pulmonaire et aortique ≥ 2 est une indication chirurgicale en cas de CIV.	569. Vrai
570. Les patients atteints de CIV dont les pressions ou les résistances pulmonaires s'élèvent doivent être opérés même si le rapport des débits pulmonaire et aortique est < 2 .	570. Vrai
571. Une résistance pulmonaire trop élevée contre-indique une chirurgie correctrice de CIV.	571. Vrai
572. Un souffle holosystolique important est audible à droite du sternum en cas de CIV.	572. Faux
573. Les shunts inter-ventriculaires sont situés principalement dans le septum membraneux.	573. Vrai
574. La seule complication de la dilatation cardiaque est l'hypertension artérielle pulmonaire.	574. Faux
575. L'ECG montre souvent des anomalies chez les patients atteints de communication inter-ventriculaire.	575. Faux